三源整合：首诊先回答三个问题

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

先区分来源，再合并临床路径

中①、中②是对同一份 2024 中国共识的解读，不是两份独立指南；西为 2025 SEMI ／ SERV 意见书。此次仅依据上传文章，未将未提供的原始共识全文或补充表视作已核对。

中① 2024 p186 、 188 （ PDF1 、 3 ）；中② 2024 p264 （ PDF1 ）；西 2025 PDF1 、 8

首诊需要回答三个问题

同步评估：病因 / 危险因素、眼部严重程度、需密切关注或立即处理的并发症。重点寻找黄斑水肿（ ME ）、无灌注区（ NP ）、眼前后节新生血管及 NVG 。

中① 2024 p187 （ PDF2 ）

眼病与全身危险因素同步管理

寻找并控制高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟等心血管危险因素，评估青光眼等局部因素。病因筛查与眼部治疗同步进行，不能因等待病因结果延误并发症治疗。

中① 2024 p187 （ PDF2 ）；西 2025 PDF2–4 、 6

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

缺血评估：阈值必须带上检测方法

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

中①：按影像方法保留缺血参考值

中①列示 CRVO：标准 7 视野 FFA 的 NP>10 个视盘面积；超广角 FFA 的 NP>75 个视盘面积及缺血指数≥35%。须结合视力、瞳孔反射及影像等判断，不把不同方法拼成一个统一必需条件。

中① 2024 p187 （PDF2）

中②：不能只凭 10 DA 贴标签

中②强调缺血型 CRVO 界定有争议，不支持只凭 10 DA；另引述无灌注可视范围 >55° 与风险的关系。角度、面积、视野范围不得自行换算或混用。

中② 2024 p266 （PDF3）

病程超过 2 个月：重视房角镜

中①：病程超过 2 个月，无论是否已见眼前节新生血管，都强调房角镜检查，以发现常规裂隙灯下不可见的房角新生血管。此为该解读的具体时间条件。

中① 2024 p187 （PDF2）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

黄斑水肿：何时观察、何时注药

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

没有统一的治疗视力切点

中②明确：启动抗 VEGF 或眼内激素的统一视力阈值尚未规定；文中 0.5 是相关试验激光对照的适应证，不应变成所有 RVO 开始注药的硬切点。

中② 2024 p265 （PDF2）

抗 VEGF： 中①给出 3+ 按需模式

中①推荐规范“3+ 按需”：首诊开始每个月注射 1 次，连续 3 次，之后按需治疗。两篇中国解读均把抗 VEGF 作为 RVO 相关 ME 的重要一线选择；后续按病情复评。

中① 2024 p187–188 （PDF2–3）；中② 2024 p265 （PDF2）

黄斑厚度需考虑设备及对照

中②指出 OCT 中央黄斑厚度受设备差异影响，优先与自身未受影响的另一眼比较；不能自身对照时参考本机构正常范围。不能自行补出统一 CMT 治疗切点。

中② 2024 p265–266 （PDF2–3）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

眼内激素：二线、特殊情境与风险

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

反应欠佳且无禁忌：考虑眼内激素

中①：抗 VEGF 反应不佳、且没有眼内糖皮质激素使用禁忌时，可考虑玻璃体腔激素缓释剂作为二线选择。不能只因水肿未完全消退就跳过病因、依从性及并发症复评。

中① 2024 p188 （PDF3）

激素作为特殊一线：严格限定情境

中①仅在抗 VEGF 绝对 / 相对禁忌（如心脑血管事件风险、妊娠等）、无眼内激素绝对禁忌，或炎性 RVO 、需降低注射频率等特殊情境考虑激素一线；不是孕妇普遍安全的替代处方。

中① 2024 p188 （PDF3）；中② 2024 p265 （PDF2）

眼内激素安全性

两篇中国解读及西意见均提示眼压升高 / 青光眼和白内障风险。选择眼内激素前核对青光眼与眼压情况，并随访相关不良反应；上传文章没有统一眼压复查日程。

中① 2024 p188 （PDF3）；中② 2024 p265 （PDF2）；西 2025 PDF6

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

新生血管与激光：治疗对象要分清

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

新生血管并发症：联合眼内与激光治疗

中②：对新生血管 /NVG 采取抗 VEGF 、适时激光光凝及降眼压治疗。中①将 PRP 用于已发生眼前后节新生血管或 NVG 的情境；抗 VEGF 不能代替相应激光处理。

中① 2024 p188 （PDF3）；中② 2024 p265–266 （PDF2–3）

不常规预防性 PRP

中① / 中②均不支持仅因缺血或 NP 而常规预防性 PRP 。中①同时强调 PRP 不能改善视功能，也不能预防非缺血向缺血型转化；应密切随访新生血管。

中① 2024 p188 （PDF3）；中② 2024 p266 （PDF3）

CRVO 不推荐黄斑格栅激光

中①指出黄斑格栅样光凝不能改善 CRVO 视功能，故不推荐。西意见亦强调眼内注射的解剖及功能获益优于格栅激光，后者使用减少。

中① 2024 p188 （PDF3）；西 2025 PDF6

BRVO 局部光凝仅特定晚期挽救

中①：病程晚期侧支循环渗漏伴 ME ，或顽固 ME 合并中心凹附近毛细血管扩张时，可考虑黄斑局部光凝挽救；早期 ME 仍以抗 VEGF 和 / 或眼内激素为一线选择。

中① 2024 p188 （PDF3）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

全身管理：抗栓建议不能混成通用处方

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

西意见：年轻或双眼者扩大检查

西 PDF5 建议 <50 岁和 / 或双眼受累者检查同型半胱氨酸、抗磷脂抗体谱，并列出遗传性血栓倾向项目。结合病史和专科评估，不将其复制成所有 RVO 的固定全套检查。

西 2025 PDF5

西意见特有：新发 CRVO 的 LMWH 疗程

西 PDF8 结论：病程 <30 天 CRVO ，在诊断后最初 10 天使用抗凝剂量 LMWH ，随后预防剂量，完成总 3 个月治疗。该意见书同时承认证据有限、缺乏明确共识；应结合其筛选情境与内科评估。

西 2025 PDF7–8

阿司匹林：需有其他独立适应证

西意见不支持仅因 RVO 启动 ASA 用于心血管一级预防；只有存在其他预防适应证时才考虑，并个体权衡风险。既有其他适应证的用药不能据这句话直接停用。

西 2025 PDF7–8

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

长期随访与原文缺项

中国共识解读 2024 | SEMI/SERV 意见 2025 · 三源整合速查 · 视网膜静脉阻塞 | 三源整合

随访至少至首诊后 2 年

中①指出病后至少 2 年仍可缓慢进展，建议每位患者定期规律随访直至首诊后至少 2 年。每次重评 ME 、新生血管、 NVG 与缺血转化，而非仅追踪视力或 OCT 水肿。

中① 2024 p188 （PDF3）

西意见的 CRVO 分型随访间隔

西意见：缺血性 CRVO 每月随访，非缺血性每 2–6 个月。整合说明：活动性 ME 正接受每月注射时，应同时遵循治疗复评安排，不以非缺血分型间隔替代月度治疗计划。

中① 2024 p187 （PDF2）；西 2025 PDF6

缺血加重或 ME 反应差：回查病因

中①：发现缺血加重或连续抗 VEGF/ 激素治疗反应不佳，应重新评估原发病因和危险因素，确认已充分发现和控制，而不是只增加眼内注射或激光。

中① 2024 p188 （PDF3）

特殊人群与危险分层缺项

三份附件未给统一危险分层评分、儿科用药表、所有眼内药物的孕哺安全分级，以及全身抗凝肝肾功能 / 体重调量细则。未明确内容保留缺项，不由本整合推断补全。

中① 2024 p187–188 （PDF2–3）；中② 2024 p265–266 （PDF2–3）；西 2025 PDF5–8

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

一页临床路径｜视网膜静脉阻塞｜三源整合

中国共识解读 2024 ｜ SEMI/SERV 意见 2025 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 确诊分型＋同步基线评估

区分 CRVO/BRVO； HRVO 按西意见说明。查视力、眼前后节、 OCT 与灌注；病因筛查同步，不延误眼部处理。

中① 2024 p187；中② 2024 p265；西 2025 PDF2–6

并发症筛查

2 有新生血管或 NVG？

查虹膜、房角及眼底。中①：病程 >2 个月强调房角镜。已发现新生血管 /NVG→3；无→ 4 。

中① 2024 p187；中② 2024 p265

有新生血管 /NVG

3 优先处理新生血管并发症

按情境联合抗 VEGF 、相应激光 /PRP 及降眼压治疗。不能以抗 VEGF 替代应做的激光；控制后→ 6 。

中① 2024 p188；中② 2024 p265–266；西 2025 PDF6

4 有影响视功能的黄斑水肿?

明显视功能损伤→ 5；视功能尚好可个体观察→ 6 。统一视力 /CMT 切点未明确； 0.5 不是通用启动阈值。

中② 2024 p265–266

视功能受损 ME

控制后随访

5 抗 VEGF 为主，按反应调整

中①：每月 1 次 ×3 次后按需；反应差且无激素禁忌，可考虑激素二线。复评病因、缺血及眼压后→ 6 。

中① 2024 p187–188；中② 2024 p265；西 2025 PDF6

复评并随访

6 持续随访＋全身协同管理

中①随访至少 2 年；西：缺血 CRVO 每月。活动性 ME 按治疗复评。新生血管或 ME 复发返回 2/4；抗栓见特定来源。

中① 2024 p187–188；西 2025 PDF6–8

跨行分支： 2→4 无上述并发症； 4→6 可观察者

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。